

Lúpus eritematoso sistêmico · flares e nefrite

LES é doença multissistêmica: combine clínica + autoanticorpos. Em prova, nefrite lúpica, serosite, citopenias e acometimento de SNC são os flares que mudam conduta.

Anticorpos

Lembre - Anticorpos

FAN é sensível, pouco específico. Anti-dsDNA e anti-Sm são mais específicos; anti-dsDNA correlaciona com atividade e nefrite. Antifosfolípides: trombose/aborto — pense SAF secundária.

Ramifique: manutenção com HCQ versus imunossupressão/internação no órgão-alvo grave.



Manejo high-yield

- Hidroxicloroquina para quase todos (salvo contraindicação) — reduz flares e trombose
- Nefrite: HA + proteinúria + sedimento ativo !' corticoterapia + MMF/ciclofosfamida conforme classe
- Evitar gestação em doença ativa; planejar com HCQ e times multidisciplinares
- Vacinas inativadas OK; atenção a imunossupressão e infecções oportunistas

Achados clássicos

Sistema | Manifestação de prova

Pele/mucosa | Malar, discoide, úlceras orais, fotossensibilidade

Rim | Proteinúria, cilindros, !'creatinina

Hematológico | Anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia

Sorologia | FAN, anti-dsDNA, consumo de complemento

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não atribua febre só a 'atividade de LES' sem excluir infecção — imunossuprimidos infectam. Em dor torácica, pense pericardite/serosite, mas também TEP se antifosfolípide.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Critérios classificatórios e classes de nefrite lúpica organizam diagnóstico e tratamento no LES.

FAN positivo como critério de entrada + pontos clínicos/imunológicos (artrite, cutâneo, renal, anti-DNA, Sm, AAF, complemento !").

Critérios classificatórios (ideia EULAR/ACR)

Entrada: FAN $\geq$ 1:80

- 1 Entrada: FAN positivo
- 2 Domínios clínicos (pele, artic, renal, neuro, serosite...)
- 3 Domínios imunológicos (DNA, Sm, AAF, C3/C4)
- 4 Somar pontos $\geq$ limiar classificatório

Prova ainda cita critérios ACR antigos (malar, discoide, fotossens., ulcera, artrite...)

Classe III/IV = proliferativa (imunossupressão agressiva). V = membranosa.

Nefrite lúpica (ISN/RPS)

Classes I-VI

I - mesangial mínima	I
II - mesangial proliferativa	II
III - focal proliferativa	III
IV - difusa proliferativa	IV
V - membranosa	V
VI - esclerose avançada	VI

III/IV: MMF ou ciclofosfamida + corticoide

Anticorpos e associação

Anticorpo | Associação clássica

Anti-dsDNA | atividade / nefrite

Anti-Sm | alta especificidade LES

Anti-Ro/La | neonatal, SCLÉ, Sjögren

Antifosfolípidos | trombose / abortamento

C3/C4 baixos | atividade, especialmente renal

Tratamento base

- Hidroxicloroquina para quase todos
- Corticoide na atividade; poupar dose com imunossupressor
- Nefrite III/IV: MMF ou ciclofosfamida + glicocorticoide
- Evitar gravidez em atividade alta; planejamento

Emergências

Atencao - Emergências

Nefrite grave, CNS lupus, trombocitopenia grave, pneumonite — corticoide IV $\pm$ imunossupressão e suporte.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1